

RỐI LOẠN LO ÂU Ở HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

Trần Thị My Lương

Học viện Phụ nữ Việt Nam

Tóm tắt: Rối loạn lo âu là một rối loạn có thể dễ gặp ở lứa tuổi học sinh Trung học phổ thông, với những yếu tố nguy cơ từ hoạt động học tập, định hướng nghề nghiệp, giao tiếp và sự phát triển thể chất... Trong bài báo này, tập trung xây dựng khái niệm, xác định các biểu hiện của rối loạn lo âu và khảo sát đánh giá thực trạng rối loạn lo âu ở học sinh Trung học phổ thông.

Từ khóa: rối loạn lo âu, học sinh THPT, rối loạn lo âu ở học sinh THPT.

Nhận bài ngày 20.4.2020; gửi phản biện, chỉnh sửa, duyệt đăng ngày 15.5.2020

Liên hệ tác giả: Trần Thị My Lương; Email: Hoangthongtinnguvan@gmail.com

1. MỞ ĐẦU

Lo âu là một hiện tượng thường gặp của con người, tuy nhiên nếu để kéo dài, có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe và cuộc sống. Người bệnh mắc rối loạn lo âu thường có sự lo lắng và nỗi sợ hãi quá mức về các tình huống hàng ngày. Giai đoạn học sinh THPT đứng trước rất nhiều áp lực khác nhau từ phía khách quan và chủ quan, dẫn đến các em có thể mắc nhiều vấn đề sức khỏe tâm thần trong đó có rối loạn lo âu.

2. NỘI DUNG

1. Đặt vấn đề

1.1. Khái niệm Rối loạn lo âu

Theo giáo trình Tâm Thần học, Nxb Quân y, khái niệm Rối loạn lo âu là sự sợ hãi quá mức, không có nguyên nhân, do chủ quan của người bệnh và không thể giải thích được do một bệnh tâm thần khác hoặc do một bệnh cơ thể. Rối loạn lo âu là rối loạn mà bệnh nhân không thể kiểm soát được, biểu hiện vững chắc, mạn tính và lan tỏa, thậm chí có thể xảy ra dưới dạng kịch phát [3]. Theo bác sĩ Nguyễn Trọng Tuấn, Bệnh viện tâm thần thành phố Hồ Chí Minh, Hội chứng: Rối loạn lo âu hay rối nhiễu lo âu là rối loạn đặc trưng bởi sự lo lắng thái quá và căng thẳng thường xuyên mà không có lý do rõ ràng. Những trải nghiệm cảm xúc lo lắng, sợ hãi thái quá này ảnh hưởng trực tiếp đến các hoạt động chức

năng của và cuộc sống của người bệnh. Rối loạn lo âu bao gồm rối loạn lo âu toàn thể, hội chứng sợ xã hội, rối loạn lo âu phân ly và rối loạn đặc hiệu. Bạn có thể mắc một hoặc nhiều rối loạn cùng lúc. Nhưng dù là bất kể dạng rối loạn nào thì cũng cần được điều trị ngay.

Tác giả Bremner định nghĩa “Rối loạn lo âu” là rối loạn tâm thần thường xuất hiện sau một yếu tố gây stress, chủ thể có cảm giác sợ hãi mơ hồ, sự bất an, bối rối khó chịu, dễ bị kích thích lo nghĩ về những sự kiện vụn vặt .. kéo theo cảm giác đau thắt ngực, đánh trống ngực, cảm giác trống rỗng vùng thượng vị, có mồ hôi. Những người bị rối loạn lo âu, trầm cảm, stress kéo dài thường có biểu hiện mất ngủ, bực bội, bất an, trí nhớ và khả năng lao động giảm sút [11]. Theo DSM-V, rối loạn lo âu bao gồm các biểu hiện của sự sợ hãi quá mức, sự lo lắng và rối loạn hành vi liên quan. Lo âu và sợ hãi đều là những tín hiệu cảnh báo trước các mối đe dọa, với lo âu là cảnh báo những đối tượng mơ hồ có thể xảy ra trong tương lai, sợ hãi là sự đón nhận đối với các đe dọa sắp xảy ra.

1.2. Rối loạn lo âu ở học sinh trung học phổ thông

Học sinh Trung học Phổ Thông là một giai đoạn cực kỳ quan trọng trong đời sống của một người. Đây là thời kỳ chuyển tiếp giữa trẻ con và người lớn, khi các em càng ngày càng mở rộng hơn về đối tượng giao tiếp, quan tâm nhiều hơn các vấn đề trong xã hội. Các em sắp trở thành một công dân thực thụ, chuyển sang giai đoạn học nghề và làm nghề để phát triển bản thân đồng thời cống hiến cho sự phát triển của xã hội. Đứng trước rất nhiều áp lực khác nhau cả khách quan và chủ quan, các em có thể mắc nhiều vấn đề sức khỏe tâm thần như Lo âu, Stress hoặc trầm cảm.

Các em có nhiều biểu hiện từ cơ thể đến tâm lý, đặc trưng như run, đổ mồ hôi, đau thắt ngực, khó tiêu, chóng mặt.. và các biểu hiện tâm lý căng thẳng hoảng sợ, đôi khi kéo dài và không kiểm soát. Ở lứa tuổi này, do sự phát triển hệ thần kinh chưa hoàn thiện, các chức năng hoạt động võ não chiếm ưu thế, việc điều khiển, điều chỉnh, kiểm soát cảm xúc chưa thuần thục cho nên dễ bị kích thích và có những suy nghĩ lệch lạc. Rối loạn lo âu ở học sinh THPT thường xuất hiện do nhóm các nguyên nhân trực tiếp tác động nhiều đến sức khỏe, nhu cầu, vị thế, vai trò, nhiệm vụ của các em. Các nghiên cứu còn chỉ ra rằng, có sự liên quan rõ rệt giữa lo âu và quá khứ phát triển của trẻ. Sự nuôi dưỡng không hợp lý của cha mẹ, ảnh hưởng các thành viên trong gia đình và nhà trường tác động đến sự hình thành tính cách, khí chất của học sinh [26].

Ngoài ra, có thể từ những nguyên nhân bệnh sinh như bệnh cấp tính, mãn tính khiến các em lo lắng về cái chết, tương lai. Cho đến những yếu tố môi trường sống như tai nạn, trộm cướp, ly dị, bạo lực, thiếu tình yêu thương chăm sóc, sự vô cảm của xã hội. Đặc biệt, giai đoạn chuyển tiếp trở thành người trưởng thành khiến các em gặp nhiều áp lực hơn trong học tập, định hướng nghề nghiệp và sự lo sợ về tương lai.

2. Kết quả khảo sát

2.1 Về khách thể và phương pháp khảo sát

Nhóm nghiên cứu gồm tác giả và Đặng Đức Anh đã tiến hành khảo sát trên học sinh trường Trung học phổ thông Chuyên, chúng tôi sử dụng phương pháp chọn mẫu ngẫu nhiên phân tầng. Với tổng số học sinh 3 khối lớp là 1457 học sinh, chúng tôi lựa chọn ra 5 lớp mỗi khối, tương ứng với 540 học sinh. Thể hiện ở bảng sau:

Bảng 2.1: Tổng số học sinh tham gia điều tra

Khối	Số lượng lớp tham gia	Số lượng học sinh tham gia điều tra sàng lọc		Tổng số học sinh điều tra
		Nam	Nữ	
10	5	62	118	180
11	5	59	121	180
12	5	60	120	180
Tổng	15	181 (33.5%)	359 (66.5%)	540

Phương pháp khảo sát

a) Phương pháp trắc nghiệm

- Mục đích:

Chúng tôi sử dụng phương pháp trắc nghiệm trong lần khảo sát đầu tiên để sàng lọc những học sinh có biểu hiện rối loạn lo âu, đánh giá mức độ lo âu để có cơ sở phân tích và phỏng vấn sâu.

- Nội dung thang đo:

Sử dụng thang đo Dass 42 để đánh giá mức độ lo âu của học sinh. Từ đó sàng lọc phân loại ra các nhóm học sinh có lo âu ở các mức độ khác nhau, tiến hành điều tra biểu hiện và các nguyên nhân dẫn đến lo âu của các em.

- Phương tiện điều tra:

Chúng tôi sử dụng thang Dass 42 là một thang đo phổ biến ở Việt Nam, đã được thích nghi hóa và sử dụng rộng rãi tại nhiều bệnh viện cũng như các phòng tâm lý tại Việt Nam.

b) Phương pháp điều tra bằng bảng hỏi:

- Mục đích:

Phiếu hỏi được sử dụng để đánh giá biểu hiện rối loạn lo âu trên 2 phương diện tâm lý và sinh lý của học sinh, bên cạnh đó chúng tôi cố gắng khai thác và tìm ra nguyên nhân gây rối loạn lo âu ở các em.

- Khách thể khảo sát bằng phiếu hỏi:

+ Có 77 học sinh có biểu hiện rối loạn lo âu sau khi sàng lọc trên 540 học sinh THPT Chuyên.

+ Phiếu hỏi được sử dụng với 77 học sinh có rối loạn lo âu.

2.2. Tỷ lệ rối loạn lo âu ở học sinh

Chúng tôi nghiên cứu 540 học sinh trong 3 khối lớp, sử dụng thang đo DASS 42 để sàng lọc số học sinh có rối loạn lo âu. Với tổng số 540 khách thể là học sinh 3 khối trường THPT Chuyên, tỷ lệ mắc rối loạn lo âu ở các em là 14,2%. Nếu so sánh trên toàn thể học sinh được nghiên cứu, mức độ lo âu nhẹ chiếm 3.5% tương ứng với 19 học sinh, lo âu mức độ vừa chiếm 7.2% tương đương 39 học sinh, lo âu mức độ Nặng chiếm 2.4% tương đương 13 học sinh và mức độ Rất nặng chiếm 1.1% tương đương 6 học sinh. So sánh với các điều tra dịch tễ trong nước và trên thế giới, tỷ lệ Rối loạn lo âu thường thấy dao động ở mức 8-20% đối với lứa tuổi thanh thiếu niên. Có thể thấy với tỷ lệ 14,7% đây là con số ở mức độ trung bình. Tỷ lệ Rối loạn lo âu mức độ rất nặng chỉ chiếm 1.1%, tức là xấp xỉ 5 học sinh. Con số này trong hạn mức cho phép, có thể đánh giá rằng tỷ lệ rối loạn lo âu của học sinh THPT Chuyên vẫn được giữ ở mức độ có thể kiểm soát. So sánh với tỷ lệ mắc rối loạn lo âu ở học sinh THPT chuyên Quảng Bình trong đề tài “Nghiên cứu một số nguyên nhân gây ra rối loạn lo âu ở học sinh” của thạc sĩ Nguyễn Thị Hằng Phương (2006) là 21.66% [19]. Thì tỷ lệ học sinh THPT Chuyên này có Rối loạn lo âu ở mức độ thấp hơn nhiều. Chúng tôi lý giải về sự khác biệt tỷ lệ giữa 2 trường chuyên đó là sự khác biệt về chương trình học, về môi trường sinh hoạt, học tập, về nhận thức của học sinh trong giai đoạn 2018 - 2019 so với những năm 2005 – 2006 được cải thiện và nâng lên rất nhiều.

Tỷ lệ Rối loạn lo âu theo tiêu chí khối lớp

Sau khi sàng lọc trên 540 học sinh, số lượng học sinh có rối loạn lo âu được chỉ ra là biểu hiện có 77 em. Phân chia theo khối lớp được thể hiện thông qua bảng sau:

Bảng 2.2. Tỷ lệ mắc rối loạn lo âu phân theo khối lớp (N = 77) (%)

	Khối lớp			Tổng
	Lớp 10	Lớp 11	Lớp 12	
Nhẹ	31.6	42.1	26.3	100
Vừa	30.8	53.8	15.4	100
Nặng	23.1	53.8	23.1	100
Rất nặng	50.0	16.7	33.3	100
Chung	31.1	48.1	20.8	100

Từ số liệu bảng 2.2 có thể thấy, xét trên tổng số 77 học sinh có rối loạn lo âu, thì số học sinh khối 10 là 24 học sinh chiếm 31.1 %, khối 11 có 3 học sinh chiếm 48.1%. Khối 12 có 16 học sinh tương ứng 20.8%.

Xét theo mức độ rối loạn lo âu Nhẹ, khối 10 có 6 học sinh trên 19 học sinh rối loạn lo âu nhẹ, tương ứng với 31.6%. Khối 11 là 8 em tương ứng 42.1%, Khối 12 có 5 em tương ứng 26.3%. Với mức độ lo âu Vừa, Khối 10 có 12 học sinh chiếm 30.8% , khối 11 có 21 học sinh chiếm 53.8% và khối 12 có 6 học sinh chiếm 15.4%. Ở mức độ lo âu Nặng, khối 10 có 3 học sinh tương đương 23.1%, khối 11 có 7 học sinh tương ứng 53.8%, khối 12 có 3 học sinh tương ứng 23.1%. Mức độ rất nặng, khối 10 có 3 học sinh trên 6 học sinh chiếm 50%, khối 11 có 1 học sinh tương ứng 16.7% và khối 12 có 2 học sinh tương ứng 33.3%. Từ những kết quả trên chúng tôi có các nhận xét như sau:

Có thể thấy rằng khi phân chia mức độ Rối loạn lo âu chung theo khối lớp thì kết quả ra được lại đáng ngạc nhiên so với giả thuyết ban đầu rằng Tỷ lệ học sinh khối 12 mắc rối loạn lo âu là cao nhất. Kết quả thực tế sau sàng lọc ở đây chỉ ra mức độ rối loạn lo âu của học sinh khối 11 cao nhất về mặt bằng chung, tức là có số lượng em học sinh chiếm 48.1% có rối loạn trên tổng 77. Khối 11 cũng có số học sinh rối loạn lo âu ở mức độ nhẹ, vừa và nặng cao hơn 2 khối 10 và 12. Đặc biệt ở mức độ vừa và nặng, số học sinh có rối loạn lo âu của khối 11 gấp 2 đến 3 lần so với 2 khối còn lại: 53.8% so với 23.1 % hay 53.8% với 30.8% và 15.4%. Ở mức độ rất nặng thì khối 10 có tỷ lệ cao nhất chiếm một nửa số học sinh, sau đó là khối 12 và khối 11.

Lý giải cho điều này, chúng tôi đã dựa trên kết quả điều tra bảng hỏi về biểu hiện và nguyên nhân cũng như qua việc phỏng vấn học sinh các khối 10,11 và 12 về biểu hiện cũng như nguyên nhân dẫn đến lo âu của các em. Nhìn chung, các em khối 11 gặp nhiều áp lực về các mặt của đời sống xã hội hơn các bạn khối 10 và 12. Các em thường xuyên băn khoăn về việc lựa chọn trường thi, ngành thi, khối thi trong tương lai, áp lực từ việc học tập và định hướng nghề khiến các em mông lung và chưa xác định được con đường mình chọn. Bên cạnh đó, các lý do khách quan được các em đưa ra như là: “Gặp rắc rối nhiều trong quan hệ bạn bè; tình yêu, trong việc ứng xử với kỳ vọng và áp lực đến từ cha mẹ và thầy cô; lo lắng và đặt áp lực lên chính bản thân mình để lựa chọn ra những phẩm chất đạo đức mà mình hướng tới”. Quan hệ xã hội của các em lớp 11 tương đối phức tạp, một phần do các bạn còn đang ở giữa khoảng thời gian học bậc học THPT, thời gian các em dành cho những suy nghĩ, chiêm nghiệm về đời sống học sinh là rất nhiều và do thiếu nguồn hỗ trợ, thông tin hướng dẫn nên các em thường mông lung, lo lắng. Còn nguyên nhân ở khối 10 là việc các em thay đổi môi trường sống, môi trường học tập, dựa theo các thông tin về học sinh THPT chuyên từ trước tới giờ, số lượng học sinh phải xa nhà, từ dưới huyện chuyển lên thường chiếm trên 50% số lượng học sinh của nhà trường. Nhiều em từ dưới huyện lên thành phố chưa thể hòa nhập và quen thuộc ngay với môi trường nơi đây. Các em ở ký túc xá hoặc ở trọ một mình nên mọi vấn đề hầu như bản thân phải tự đối diện và giải quyết.

Còn khối 12, áp lực học tập là nguyên nhân chính khiến cho các em lo âu. Dù vậy, đa số các em đều đã xác định được lực học của mình, kết quả học tập qua các kỳ thi không còn nhiều dao động, các em cũng chọn được hướng đi cho mình khi đã bước vào lớp 12. Khả năng tư duy, sắp xếp giải quyết vấn đề của khối 12 cũng tốt hơn khối 10 và khối 11. Những áp lực của các em đều tập trung chính vào việc học tập và thi cử, không còn bị phân tán quá nhiều sang các lĩnh vực khác.

Tỷ lệ mắc rối loạn lo âu theo tiêu chí giới.

Bảng 2.3: Tương quan học sinh có rối loạn lo âu phân theo giới (%)

Giới tính	Số lượng học sinh có biểu hiện RLLA	Tỷ lệ %	
		% học sinh có rối loạn theo giới trên số học sinh	% học sinh có rối loạn theo giới trên tổng số học

		được khảo sát theo giới	sinh có rối loạn
Nam	16	8.8%	20.7%
Nữ	61	16%	70.9%

Trong tương quan với tiêu chí giới, tổng số học sinh Nam có Rối loạn lo âu là 16, trên 181 em nam sinh được khảo sát. Kết quả tương ứng với 8.8%. Tỷ lệ phần trăm trên tổng số học sinh có rối loạn lo âu là 20.7%. Còn đối với nữ giới, có 61 em mắc Rối loạn lo âu trên 381 học sinh nữ tham gia khảo sát, tỷ lệ phần trăm tương ứng là 16%. Chúng ta nhận ra có sự chênh lệch giữa Nam và Nữ mắc rối loạn lo âu khi so sánh số học sinh có rối loạn theo giới với tổng số học sinh tham gia khảo sát ban đầu. Tỷ lệ nữ sinh có rối loạn cao hơn so với số nam sinh có rối loạn, kết quả này cũng là kết quả thường thấy trên hầu như các khảo sát dịch tễ về thực trạng rối loạn lo âu nói riêng và một số rối nhiễu tâm lý nói chung.

Bảng 2.4: Tỷ lệ rối loạn lo âu trên các mức độ khác nhau phân theo giới (%)

	Nhẹ	Vừa	Nặng	Rất nặng	Tổng
Nam	18,7	56,3	12,5	12,5	100
Nữ	26,2	49,2	18,0	6,6	100

Tỷ lệ mắc rối loạn lo âu theo giới, với nam sinh, mức độ lo âu vừa có tỷ lệ cao nhất chiếm 56.3% gấp 3 lần so với mức độ lo âu nhẹ và gần 5 lần so với mức độ lo âu nặng, rất nặng. Ở nữ giới, mức độ lo âu vừa cũng chiếm tỷ lệ cao nhất với 49.2%, gần gấp 2 lần so với mức độ nhẹ và gần gấp 3 lần so với mức độ nặng. Tỷ lệ nữ sinh có lo âu ở mức độ rất nặng khá thấp, bằng 1/8 lần so với tỷ lệ lo âu mức độ vừa.

Nhìn chung mức độ lo âu Vừa có tỷ lệ cao nhất so với các mức độ còn lại, chiếm 1 nửa hoặc hơn 50% trên cả 2 giới. Các mức độ Nhẹ, Nặng, Rất nặng có sự chênh lệch giữa Nam và Nữ nhưng không đáng kể. Ở Nam, mức độ nặng và rất nặng có tỷ lệ ngang bằng, và đều thấp hơn mức độ nhẹ. Ở nữ, kết quả của rất nặng lại thấp nhất, bằng 1/3 so với tỷ lệ lo âu nặng. Sự chênh lệch giữa các mức độ nhẹ, nặng, rất nặng ở nữ cao hơn ở nam giới.

Tóm lại, qua phân tích về tỷ lệ học sinh có Rối loạn lo âu ở trường THPT Chuyên, chúng tôi có các nhận xét sau:

Với tổng số học sinh tham gia khảo sát là 540, có 77 em rối loạn lo âu, tỷ lệ mắc tương ứng là 14.2 %, nếu so với các khảo sát dịch tễ trước đây về các rối nhiễu tâm lý nói chung và về rối loạn lo âu nói riêng ở học sinh, thanh thiếu niên thì đây là một kết quả ở mức trung bình, không quá cao tuy nhiên cũng đặt ra những thách thức cho các em, với cha mẹ, nhà trường và các đội ngũ sức chăm sóc sức khỏe, tâm lý chuyên trách. Tỷ lệ mắc rối loạn lo âu theo khối lớp, ở học sinh khối 11 nhìn chung cao nhất, sau đó là đến khối 10 và thấp nhất lại là khối 12. Có lẽ do sự trưởng thành về mặt nhận thức và năng lực tư duy giải quyết vấn đề của các em khối 12 cao hơn so với các em học sinh khóa dưới nên dẫn tới tỷ lệ như vậy.

Về tỷ lệ học sinh có rối loạn lo âu phân theo giới tính, các em học sinh nữ Chuyên có xu hướng mắc rối loạn lo âu cao hơn các bạn học sinh nam. Cụ thể trong nghiên cứu này tỷ lệ có rối loạn lo âu của các em nữ là 16% gần gấp đôi các em nam 8.8%. So với kết quả nghiên cứu ở những đề tài khác: Tỷ lệ các rối nhiễu tâm lý như rối loạn lo âu, trầm cảm, stress ở nữ cũng thường nhiều hơn nam thì kết quả này nằm trong dự đoán của chúng tôi.

2.3. Biểu hiện rối loạn lo âu của học sinh THPT

Chúng tôi điều tra về biểu hiện trên 77 học sinh có rối loạn lo âu sau sàng lọc bằng thang Dass 42. *Biểu hiện về mặt cơ thể, sinh lý:*

Bảng 2.5. Biểu hiện thể chất, sinh học của các em có rối loạn lo âu

Biểu hiện	Chưa bao giờ	Thỉnh thoảng	Thường xuyên	Rất thường xuyên	Số lượt ghi/ Sắp xếp theo thứ tự (Phần trăm tỷ lệ)
Có cảm giác nóng ruột, gan	29	43	4	1	48/4 (62.3%)
Cảm giác lão đảo chân đi không vững	44	33	0	0	33/10
Cơ thể căng cứng không thể thư giãn	32	39	4	2	35/8
Đau đầu, đau nửa đầu	11	43	14	9	45/5 (58.4%)
Rối loạn nhịp thở	43	19	15	0	34/9
Mặt mình nóng phùng phùng	22	42	11	2	55/3 (68.8%)
Cảm giác tê buốt như kiến bò ở đầu ngón tay , ngón chân	47	18	11	1	30/11
Tiểu tiện nhiều	40	33	4	0	37/7 (48 %)
Ngủ gặp ác mộng	44	25	7	1	33/10
Cảm giác khô miệng	36	33	8	0	41/6 (53.2%)
Run rẩy cơ thể, tay chân	40	33	4	0	37/7 (48%)
Đổ mồ hôi dù không vận động nhiều hoặc trời không nóng	40	22	11	4	37/7 (48%)
Nghẹn cổ họng, khó nuốt	50	22	5	0	27/12
Choáng váng, chóng mặt, hoa mắt	11	54	11	1	66/1 (85.7%)
Tăng phản xạ, dễ bị kích động	40	26	4	7	37/7 (48%)
Rối loạn giấc ngủ, khó ngủ	29	23	25	0	48/4 (62.3%)
Nhịp tim tăng nhanh, đánh trống ngực	47	22	7	1	30/11
Tê bì, ngứa ngáy	72	4	0	0	4/13
Khó tập trung chú ý, trí nhớ trống rỗng	18	29	25	5	59/2 (76.6 %)

Nhìn chung, sau khi xử lý thông tin trong các câu hỏi 1, 2 của bảng hỏi, kết quả thu được trên 77 phiếu như sau: Các em đa phần đều có sự giảm sút về mặt sức khỏe, về thể chất, trong số 77 học sinh, có tới 85.7% học sinh có biểu hiện choáng váng, chóng mặt, hoa mắt. Biểu hiện cao thứ 2 đó chính là khó tập trung chú ý, trí nhớ trống rỗng với 76.6% trên tổng số học sinh có rối loạn lo âu. Có 62.3% học sinh mang biểu hiện rối loạn giấc ngủ, khó ngủ và nóng ruột, gan, bồn chồn. Biểu hiện mà có mức độ rất thường xuyên cao nhất chính là đau đầu và đau nửa đầu.

Biểu hiện về mặt tâm lý:

Bảng 2.6. Biểu hiện về tâm lý của những học sinh có rối loạn lo âu

Biểu hiện	Chưa bao giờ (số lần chọn/ tỷ lệ %)	Thỉnh thoảng	Thường xuyên	Rất thường xuyên	Sắp xếp theo thứ tự
Lo sợ một điều gì đó rất xấu sắp xảy ra	22	33	18	4	55/4 (71.4%)
Cảm thấy khiếp sợ	40	32	4	1	37/9
Lo sợ mất khả năng kiểm soát bản thân	40	29	1	7	37/9
Hay nghĩ về những bi kịch, cái chết	36	29	11	1	41/8 (53.2%)
Tôi cảm thấy nóng nảy và lo âu hơn thường lệ	44	22	11	0	33/11
Tôi dễ bối rối và cảm thấy hoảng sợ vô cớ	55	7	15	0	22/14
Tôi cảm thấy yếu và dễ mệt mỏi	11	51	11	4	66/1 (85.7%)
Tôi thường có ác mộng	58	11	7	1	19/15
Tôi sợ phải làm những việc tuy bình thường nhưng trước đây tôi chưa từng làm bao giờ	61	15	1	0	16/16
Tôi lo lắng về những tình huống có thể làm tôi hoảng sợ hoặc biến tôi thành trò cười	15	51	11	0	62/3 (80.5%)
Cảm giác lo lắng hay cảm giác bị đe dọa một cách mơ hồ, dai dẳng	54	18	5	0	23/13
Rất hay trong trạng thái bồn chồn, hồi hộp	25	43	7	2	52/5 (67.5%)
Cảm giác kích động, bức bối	25	43	5	4	52/5 (67.5%)
Tri giác sai thực tại, giải thể thực tại hoặc giải thể nhân cách	72	1	0	0	1/17
Khó tập trung chú ý hoặc đầu óc trống rỗng	22	32	22	1	55/4 (71.4%)
Dễ cáu gắt bức bối vì những chuyện không đáng	11	43	15	8	66/1 (85.7%)
Thất vọng về bản thân, cảm thấy vô dụng, bất lực	25	29	14	9	52/5 (67.5%)
Không muốn giao tiếp với người khác	36	32	7	2	41/8
Tránh tiếp xúc với những mối quan hệ xã hội	36	36	4	1	41/8

Hay có những suy nghĩ tiêu cực	33	26	7	11	44/7
Đễ hoảng loạn với những vấn đề trước mắt	43	32	1	1	34/10
Tinh thần suy sụp, sụp đổ	43	25	7	2	34/10
Do dự, rất kkhhi phải đưa ra quyết định	14	43	18	2	63/2 (81.8%)
Cảm thấy không ai hiểu mình, chia sẻ với mình	22	29	15	11	55/4 (71.4%)
Cảm thấy có quá nhiều thứ có thể gây nguy hiểm cho mình	51	22	0	4	26/12
Vẫn luôn lo lắng, đề phòng kể cả khi vấn đề đã qua đi	32	32	11	2	45/6 (58.4%)

Từ thông tin bảng hỏi trên, chúng ta có thể nhận thấy có tới 85.7% học sinh có biểu hiện bất thường “hay cáu gắt với những chuyện không đáng có” và “dễ yếu và dễ mệt mỏi”. Xếp thứ 2 là “Do dự, rất khó khăn khi phải đưa ra các quyết định” với 81.8%. Biểu hiện thứ 3 được rất nhiều bạn lựa chọn đó chính là “Tôi lo lắng về những tình huống có thể làm tôi hoảng sợ hoặc biến tôi thành trò cười” với 80.5% tương ứng 62//77 học sinh lựa chọn. Các biểu hiện khác thường khác ở mặt tâm lý với lựa chọn đều trên 50% là “lo sợ điều gì rất xấu sẽ xảy ra ” hoặc “luôn trong trạng thái bồn chồn, hồi hộp”, “trong trạng thái kích động, bức bối” . Cũng có nhiều em mang suy như tiêu cực “thất vọng về bản thân và cảm giác vô dụng, bất lực”.

Học sinh THPT chuyên đa phần đều là những học sinh có nền tảng rất tốt, các em thường có năng khiếu và kiến thức vượt trội trong một lĩnh vực nào đó, việc các em cảm thấy mình bất lực, vô dụng dường như đối nghịch lại rất nhiều cách nhìn của mọi người đối với các em. Có thể do các em đã có những nhận thức về năng lực bản thân rất tốt, các em nhận ra có quá nhiều thứ mình muốn làm nhưng trong tầm khả năng lại chưa thể làm được, hoặc các em cũng chịu áp lực, kỳ vọng từ nhiều phía xung quanh dẫn đến tình trạng cảm thấy bất lực khi không thể làm việc gì. Khi chịu nhiều kỳ vọng, áp lực, lúc này danh tiếng học sinh Chuyên lại càng như một tác nhân khiến các em suy nghĩ tiêu cực hơn về bản thân mình. Có những em học sinh thuật lại “Lần nào em thi xong cũng bị so sánh, họ nói em là học sinh Chuyên mà mấy cái đó cũng không làm được, em thấy tệ quá, em cảm thấy thật vô dụng với mác học sinh Chuyên này, em rất lo sợ cảm giác này khi kỳ thi sắp đến ”. Mệnh đề “cảm thấy bản thân vô dụng, bất lực” cũng là mệnh đề có tỷ lệ lựa chọn “Rất thường xuyên” cao nhất.

Chúng tôi cũng lồng ghép một vài mệnh đề mô tả trạng thái của các loại rối loạn lo âu khác ngoài rối loạn lo âu lan tỏa như của rối loạn hoảng sợ, rối loạn sợ xã hội. Các mệnh đề như “nghĩ đến cái chết, nghĩ đến bị kịch” hay “sợ phải giao tiếp với người khác, các mối quan hệ xã hội ” đều có sự lựa chọn với tỷ lệ trên 50%.

3. KẾT LUẬN

Lứa tuổi học sinh THPT trải qua những bước ngoặt quan trọng trong học tập, định hướng nghề nghiệp, giao tiếp thầy cô bạn bè,... Những yếu tố nguy cơ này có thể làm nảy sinh biểu hiện rối loạn lo âu ở các em, bao gồm các biểu hiện về sinh lí và tâm lí. Những nghiên cứu về đề tài này rất cần để tiếp nối với định hướng trong việc chăm sóc, hỗ trợ tâm lí cho các em.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Nguyễn Thị Minh Hằng, Trần Thành Nam, Nguyễn Bá Đạt, Nguyễn Ngọc Diệp (2016), *Giáo trình Tâm lý học lâm sàng*, Nxb. Đại học Quốc gia Hà Nội.
2. Dương Thị Diệu Hoa (2007), *Giáo trình tâm lý học phát triển*, Nxb Đại học sư phạm.
3. Võ Văn Bản (2002), *Các rối loạn lo âu*, Nxb Y học.
4. Lê Văn Hồng, Lê Ngọc Lan (2001), *Tâm lý học lứa tuổi và tâm lý học sư phạm*, Nxb. Giáo dục, Hà Nội.
5. Bùi Quang Huy (2017), *Rối loạn lo âu*, Nxb. Y học.
6. Nguyễn Công Khanh (1995), “*Tư vấn và trị liệu tâm lý cho trẻ em có rối nhiễu hành vi và khó khăn học đường*”, Hội thảo Việt - Pháp về Tâm lý học Hà Nội.
7. Nguyễn Thị Phương Mai (2014). *Nghiên cứu biểu hiện rối loạn lo âu ở học sinh trường trung học cơ sở Phương Mai - Hà Nội khi sống trong gia đình có bạo lực*.
8. Trần Thị Thu Mai, Nguyễn Ngọc Duy (2015), Rối loạn lo âu của sinh viên một số trường Sư Phạm tại thành phố Hồ Chí Minh, *Tạp chí khoa học ĐHSP TPHCM*.
9. Nguyễn Văn Siêm, *Tâm bệnh học trẻ em và thanh thiếu niên*, Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội
10. Hồ Hữu Tính, Nguyễn Doãn Thành (2010), Thực trạng stress lo âu và những liên quan đến lo âu ở học sinh cấp 3 trường THPT Phan Bội Châu, Phan Thiết, Bình Thuận, *Tạp chí Y học TP Hồ Chí Minh*.
11. Nguyễn Thị Vân (2017), *Nghiên cứu thực trạng và giải pháp can thiệp tâm lý đối với tình trạng rối loạn lo âu ở học sinh trung học phổ thông tại thành phố Hồ Chí Minh*.

ANXIETY DISORDERS IN HIGH SCHOOL STUDENTS

Abstract: Anxiety disorder is a disorder that can be easily encountered in high school students. It could be the consequence of the risk factors from learning activities, career orientation, communication, and physical development ... This article focuses on the concepts, identifying the manifestations of anxiety disorders and surveying, and assessing the situation of anxiety disorders in high school students.

Keywords: Anxiety disorder, high school student, anxiety disorder in high school student.